



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

KOMISI ETIK PENELITIAN

Jalan Dr. Setiabudi No.229 Bandung 40154

Telepon: +62852-2462-6865

Laman: etikpenelitian.upi.edu e-mail: etikpenelitian@upi.edu

Formulir Pengajuan Telaah Etik Baru

Diisi oleh Peneliti

Nomor Registrasi		Tanggal Pengajuan	20 februan 2025
Jenis Etik Penelitian • Etik Uji Sosial Humaniora ○ Etik Non Uji Klinik ○ ☒ Etik Uji Klinik ○ Etik Uji Hewan		Keterangan Lainnya:	

JUDUL PROPOSAL:

ASUTAN KEPERAWATAN PADA PASIEN ULKUS DEUBITUS DENGAN PENERAPAN HYDROCOL DALAM PROSES PENYEMBUHAN WET DI RSUD UMAR WIRATADI-KUSUMAH

PEMBERI DANA:	Mandiri
PENELITI UTAMA:	
Nama Lengkap:	Ayu Andini Triana, S.kep
Lembaga:	Universitas pendidikan Indonesia Kampus Daerah Sumedang
No Telp (HP):	081386408611
E-mail:	ayuanandini@upi.edu

PENELITI YANG BERPARTISIPASI:

Nama Lengkap	Lembaga	E-mail	Nomor Telp (HP)
Ayu Andini Triana...S.kep	UPI Kampus Sumedang	ayuanandini@upi.edu	081386408611
Popi Sophia S. Kep, M. Biomed	UPI Kampus Sumedang	popisophia@upi.edu	08215096951
Durasi Penelitian	1 Bulan		
Tanggal mulai	01 Maret 2025		



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

KOMISI ETIK PENELITIAN

Jalan Dr. Setiabudi No.229 Bandung 40154

Telepon: +62852-2462-6865

Laman: etikpenelitian.upi.edu e-mail: etikpenelitian@upi.edu

Lokasi Penelitian:	RSUD Umar Wirahadikusumah
Jumlah Total Subjek Penelitian:	1 (satu)
Kisaran Umur:	20 tahun - 30 tahun

Subyek Studi:

- ☒ Manusia (studi yang melibatkan subjek manusia; diperlukan persetujuan yang diinformasikan)
 - ☒ Eksperimental
 - ☒ Studi observasi
- ☐ Data Sekunder (studi menggunakan data yang ada misalnya statistik, survei nasional/regional yang ada)
- ☐ Hewan (studi tentang hewan laboratorium) (secara otomatis ditautkan ke Penelitian yang Melibatkan Bentuk Hewan)
- ☐ In Vitro: studi tentang garis sel komersial mikroba, specimen patologis/manusia yang tidak terkait (dibutakan) ke pengenalan manusia (pemilik spesimen tidak diketahui/tidak teridentifikasi), dll.

Tanggung Jawab Etis dan Pernyataan Conflict of Interest (COI)

"Dengan ini saya berjanji untuk menangani semua bentuk COI yang mungkin saya miliki dan melakukan tugas saya secara objektif, melindungi integritas ilmiah penelitian, melindungi semua peserta manusia dan mematuhi tanggung jawab etika saya sebagai peneliti."

Dokumen yang dilampirkan:

Peneliti Utama,



Ayu Andini Triana



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

KOMISI ETIK PENELITIAN

Jalan Dr. Setiabudi No.229 Bandung 40154

Telepon: +62852-2462-6865

Laman: etikpenelitian.upi.edu e-mail: etikpenelitian@upi.edu

No.	Dokumen	Ya	Tidak
1.	Surat pengantar dari institusi	✓	
2.	Proposal/protokol sudah disahkan	✓	
3.	Formulir penjelasan kepada calon subjek penelitian	✓	
4.	<i>Informed Consent Form</i> (ICF) - lembar persetujuan setelah penjelasan	✓	
5.	Alat pengumpulan data, contoh: panduan wawancara, FGD, kuesioner	✓	
6.	Daftar nama tim peneliti	✓	
7.	CV peneliti	✓	
8.	Anggaran penelitian	✓	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
KAMPUS UPI DI SUMEDANG
PRODI PROFESI NERS

Jl. Margamukti No. 93 Licin Cimalaka Sumedang 45353 Telp. / Fax. (0261) 203084 / 205172
homepage : kd-sumedang.upi.edu | email : dirkamda_smd@upi.edu

Nomor : T-695/UN.40.C2/KM.00.04/2025
Lampiran : 1 berkas
Hal : Surat Pengantar

19 Februari 2025

Kepada Yth. :
Komite Etik UPI Bandung

di Bandung

Dengan hormat,

Bersama ini kami **Ayu Andini Triana NIM : 2411428** menyampaikan Proposal lengkap dengan judul “Asuhan Keperawatan Pada Pasien Ulkus Decubitus Dengan Penerapan Hydrogel Dalam Proses Penyembuhan Luka di RSUD Umar Wirahadikusumah ” yang disusun oleh periset untuk mendapatkan persetujuan dari Komite Etik Penelitian Kesehatan dengan persyaratan terlampir. Proposal ini secara substantif telah mendapatkan rekomendasi dari Pembimbing Penelitian kampus.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

Direktur,


Dr. Indra Safari, M.Pd.
NIP. 197709022008011016

PROPOSAL PENELITIAN
ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN ULKUS DEKUBITUS
DENGAN PENERAPAN *HYDROGEL* DALAM PROSES PENYEMBUHAN
LUKA DI RSUD UMAR WIRAHADIKUSUMAH

KARYA ILMIAH AKHIR NERS

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Ners
pada jenjang Pendidikan Profesi Ners



Disusun oleh:

Nama : Ayu Andini Triana

NIM : 2411428

Program Studi : Profesi Ners

PROGRAM STUDI PROFESI NERS
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
KAMPUS SUMEDANG

2024

DAFTAR ISI

COVER	
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan	4
BAB II TINJAUAN LITERATURE	5
2.1 Definisi Ulkus Dekubitus	5
2.2 Etiologi Ulkus Dekubitus	5
2.3 Manifestasi Klinis Ulkus Dekubitus	6
2.4 Klasifikasi Ulkus Dekubitus	6
2.5 Patofisiologi	8
2.6 Pemeriksaan Diagnostik	9
2.7 Penatalaksanaan Ulkus Dekubitus	9
2.8 Komplikasi Ulkus Dekubitus	10
2.9 Anatomi Fisiologi Kulit	11
2.10 Proses Penyembuhan Luka	11
2.11 Standar Operasional Prosedur	14
BAB III METODE PENELITIAN	19
3.1 Jenis Penelitian	19
3.2 Lokasi Penelitian	19
3.3 Subjek Penelitian	19
3.4 Teknik Sampling dan Besar Sampel	19
3.5 Rancangan/Desain Penelitian	20
3.6 Alat dan Bahan Penelitian	20
3.7 Cara Kerja Penelitian	20
3.8 Teknik Analisis Data	21
3.9 Jadwal Penelitian	21
DAFTAR PUSTAKA	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ulkus dekubitus atau tirah baring lama adalah terjadi luka pada kulit dan jaringan di bawah kulit yang diakibatkan tekanan dalam rentang waktu yang lebih lama atau berkepanjangan terutama terjadi di area tubuh yang bertulang misalnya seperti sakrum, tumit, trokanter mayor, ishium, malleolus (umumnya terjadi pada sisi lateral), dan oksiput. Kondisi ini sering dialami oleh orang-orang dengan mobilitas terbatas, sehingga mereka sulit untuk mengubah posisi tubuh secara mandiri tanpa bantuan. (Zaidi & Sharma dalam Alzamani, L. M. H. I., dkk, 2022).

Insiden ulkus dekubitus di seluruh dunia diperkirakan mencapai 33% artinya itu adalah salah satu masalah kesehatan serius di fasilitas perawatan akut dan kronis. Pasien yang diobati dan dirawat di ruang intensif memiliki risiko lebih tinggi mengalami dekubitus dengan prevalensi 41%. Biasanya, ulkus dekubitus berkembang selama dua minggu pertama perawatan dan sekitar 54% dari kasus baru terjadi setelah pasien dirawat di fasilitas kesehatan tersebut. (Pranarka, dalam Alzamani, L. M. H. I., dkk, 2022).

Lanjut Usia (Lansia) adalah individu yang telah berusia diatas 60 tahun, terutama mereka yang telah berusia lebih dari 70 tahun lebih rentan terhadap ulkus dekubitus. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan ulkus dekubitus seperti hilangnya sensitivitas sensorik, gangguan kesadaran, dan penurunan mobilitas bisa membuat pasien tidak menyadari ketidaknyamanan yang ditimbulkan oleh tekanan, sehingga mereka tidak mengubah posisi tubuhnya, ada juga faktor eksternal yang dapat memperburuk kondisi pasien sehingga menyebabkan ulkus dekubitus seperti tekanan yang berkepanjangan, gesekan, dan juga kelembaban. (Zaidi & Sharma dalam Alzamani, L. M. H. I., dkk 2022).

Insidensi ulkus dekubitus yang sangat tinggi dapat berdampak langsung pada kualitas pelayanan kesehatan, terutama terkait perawatan dan juga

lama rawat inap pasien. Beberapa upaya pencegahan yang dapat dilakukan seperti perawatan luka, penggunaan obat topikal, kasur terapi, serta edukasi pasien dan keluarga dapat dilakukan untuk mengurangi komplikasi dan memperbaiki kualitas perawatan pada pasien. (Sura, E., Langitan, A., Sabir, M., & Tulaka, 2023)

Dampak terjadinya ulkus dekubitus pada kualitas hidup pasien sangat signifikan. Kondisi ini sering kali menyebabkan rasa nyeri yang hebat, terutama ketika luka berkembang ke tahap yang lebih dalam, yang bisa membatasi gerakan dan juga aktivitas sehari-hari pasien. Akibatnya, pasien tidak bisa melakukan mobilitas secara aktif dan menjadi ketergantungan kepada orang lain untuk melakukan tugas - tugas sederhana. Selain rasa nyeri yang dialami, ulkus dekubitus yang tidak segera ditangani juga dapat menyebabkan infeksi pada luka, mulai dari infeksi ringan sampai dengan terjadi infeksi berat seperti osteomielitis (infeksi tulang) atau bahkan sepsis, yang dapat mengancam nyawa pasien. (Zaidi & Sharma dalam Alzamani, L. M. H. I., dkk 2022).

Oleh karena itu, pencegahan sangat penting untuk mengurangi terjadinya komplikasi infeksi pada kejadian ulkus dekubitus. Dalam mengatasinya agar tidak berlanjut komplikasi maka dapat dilakukan perawatan luka. Perawatan luka yang optimal mempunyai peranan penting dalam proses penyembuhan luka supaya dapat berlangsung dengan baik tanpa terjadi komplikasi. (Sudarta, 2022) Perawatan luka konvensional umumnya dilakukan dengan sering mengganti pembalut pada luka, berbeda dengan perawatan luka modern yang memiliki prinsip yaitu menjaga luka tetap lembab seperti dengan memakai bahan seperti *hydrogel*. *Hydrogel* ini mampu menciptakan kelembaban pada lingkungan area luka, melunakkan serta mampu menghancurkan jaringan nekrotik/jaringan yang sudah mati tanpa merusak jaringan sehat pada area luka. Perawatan luka dengan Prontosan Gel dapat memberikan kelembaban bagi area luka serta tidak menyebabkan nyeri pada proses pembersihan luka (Sudarta, 2022)

Penelitian Rizaldi (2019) menunjukkan hasil penelitiannya bahwa

perawatan luka pada ulkus diabetic / luka diabetes dengan teknik *moist healing* membuktikan lebih cepat membantu proses penyembuhan luka dibandingkan dengan *wet dry*, teknik *moist healing* mampu membantu ulkus diabetikum cepat membaik dan sembuh. Sejalan dengan penelitian oleh Wahyuni (2021) yang menggunakan penerapan teknik *moist wound healing* pada perawatan ulkus decubitus dengan hasil luka mengalami regenerasi setelah dilakukan perawatan luka dengan waktu selama 7 hari, karena luka dalam keadaan yang lembab mampu membantu meningkatkan proses mitosis, mengurangi terjadinya nyeri dan juga trauma saat ganti balutan luka, dan membantu pergerakan sel pada luka dekubitus, sehingga mempercepat terjadinya regenerasi sel pada luka dekubitus, maka dari itu peneliti ingin melakukan penerapan *hydrogel* pada ulkus decubitus dengan tujuan untuk mempercepat proses penyembuhan luka.

RSUD Umar Wirahadikusumah merupakan Rumah Sakit yang berada di Kota Sumedang, Jawa Barat. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari wawancara dan observasi dengan perawat di RSUD Umar Wirahadikusumah bahwa tidak ada pasien yang mengalami kejadian ulkus dekubitus selama perawatan di RS, akan tetapi pasien yang sudah mengalami ulkus dekubitus dari rumah yang mengalami tirah baring terlalu lama di rumah sehingga mereka dibawa ke RS untuk dilakukan perawatan dan intervensi yang sesuai dengan kondisi pasien tersebut.

Ulkus dekubitus yang terjadi pada lansia sering kali disebabkan karena ketidakmampuan lansia dalam melakukan perawatan diri sehingga mereka menjadi tergantung kepada orang lain., sehingga yang terjadi sejatinya dapat dicegah melalui beberapa intervensi sederhana seperti pemberian *hydrogel* yang masih jarang digunakan. Berdasarkan data tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat topik mengenai "Asuhan Keperawatan Pada Pasien Ulkus Dekubitus Dengan Penerapan *Hydrogel* Dalam Proses Penyembuhan Luka Di Rsud Umar Wirahadikusumah".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti membuat rumusan untuk penelitian ini yaitu “Bagaimana penerapan *hydrogel* dalam melakukan perawatan ulkus decubitus? “.

1.3 Tujuan

Tujuan melakukan penelitian *case report* ini adalah untuk melakukan perawatan ulkus decubitus dengan teknik penerapan *hydrogel* terhadap penyembuhan luka decubitus.

BAB II

TINJAUAN LITERATUR

2.1 Definisi Ulkus Dekubitus

Ulkus dekubitus adalah luka pada kulit dan jaringan lunak yang terbentuk karena tekanan yang terus menerus atau dalam waktu yang lama pada kulit. Ulkus ini dapat terjadi di area tulang tubuh seperti ishium, trokanter mayor, sakrum, tumit, malleolus (lateral daripada medial), dan oksiput. Lesi ini sebagian besar terjadi pada orang yang mobilitasnya menurun sehingga sulit dalam mengubah posisi tubuhnya (Zaidi dan Sharma, 2021).

2.2 Etiologi Ulkus Dekubitus

Ulkus dekubitus disebabkan karena kematian jaringan yang dihasilkan dari penghentian suplai darah ke organ terpengaruh. Pembuluh darah membawa sel-sel darah merah yang pada gilirannya membawa kehidupan memberi oksigen untuk semua jaringan. Darah juga membawa nutrisi, seperti glukosa, asam amino, dan asam lemak yang penting untuk fungsi normal jaringan. Infeksi menyebabkan pembengkakan terkena organ dan penghentian aliran darah. Orang-orang dengan sistem kekebalan yang lemah juga rentan terhadap infeksi yang dapat menyebabkan gangren. Orang-orang ini meliputi: orang-orang dengan HIV AIDS, orang-orang dengan kanker dan kemoterapi dan radioterapi, perokok, jangka panjang pecandu alkohol, jangka panjang obat pelaku, penderita diabetes, orang-orang dengan kekurangan gizi atau kekurangan diet, orang tua, gemuk/kelebihan berat badan, orang-orang dengan jangka panjang akhir tahap penyakit ginjal (Nanda, 2010 dalam Sri, 2022). Penyebab dari ulkus dekubitus, yaitu:

- a. Gangguan makroangiopati (kerusakan pembuluh darah besar) berupa terjadinya aterosklerosis.
- b. Gangguan mikroangiopati (kerusakan pembuluh darah kecil) pada tungkai bawah yang mengakibatkan aliran darah pada bagian tersebut

berkurang.

- c. Gangguan mikrovaskular misalnya pembuluh-pembuluh darah kapiler, kerusakan endotel, gangguan fungsi sel darah putih.
- d. Gangguan neuropati, merupakan kerusakan jaringan saraf sehingga fungsinya akan terganggu.
- e. Infeksi, proses ulserasi (mengoreng) berupa ulkus atau pembentukan gangren (pembusukan) sebagai akibat gangguan pembuluh darah dan saraf, infeksi akan menyebar ke mana-mana antara lain tulang dan sendi (Sri, 2022).

2.3 Manifestasi Klinis Ulkus Dekubitus

Tanda dan gejala ulkus dekubitus sebagai berikut (Alzamani et al., 2022) :

- 1. Sering mengalami kesemutan
- 2. Nyeri pada kaki saat istirahat
- 3. Sensasi atau sensitivitas rasa berkurang
- 4. Kerusakan pada jaringan (nekrosis)
- 5. Penurunan denyut nadi arteri dorsalis pedis, tibialis, dan poplitea
- 6. Kaki menjadi atrofi, dingin, dan kuku menebal

2.4 Klasifikasi Ulkus Dekubitus

Menurut National Pressure Ulcers Advisory Panel (NPUAP), luka tekan dibagi menjadi empat stadium, yaitu:

- 1. Stadium 1:
 - a. Adanya perubahan dari kulit yang dapat diobservasi. Apabila dibandingkan dengan kulit yang normal, maka akan tampak salah satu tanda sebagai berikut: perubahan temperatur kulit (lebih dingin atau lebih hangat)
 - b. Perubahan konsistensi jaringan (lebih keras atau lunak)
 - c. Perubahan pada sensasi (terasa gatal atau nyeri)
 - d. Pada orang dengan kulit lebih terang, luka mungkin akan terlihat sebagai kemerahan yang menetap. Sedangkan pada yang berkulit gelap, luka akan terlihat sebagai warna merah yang menetap, biru atau ungu.

2. Stadium 2:

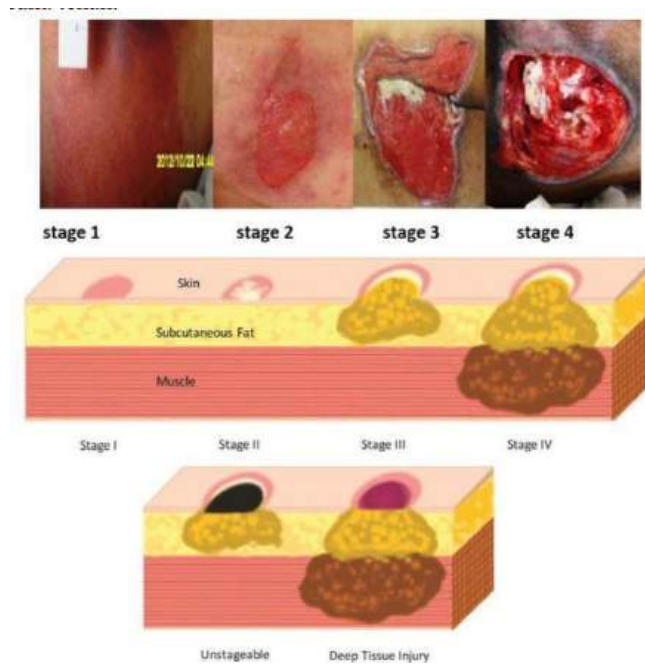
Lapisan kulit yang hilang sebagian yaitu epidermis, dermis, atau keduanya. Ciri - cirinya adalah luka superficial, abrasi, melepuh, atau terbentuk seperti lubang yang dangkal.

3. Stadium 3:

Lapisan kulit yang hilang secara lengkap, yang meliputi kerusakan atau nekrosis dari jaringan subkutan atau yang lebih dalam, tetapi tidak sampai pada fascia, luka terlihat seperti lubang yang dalam.

4. Stadium 4:

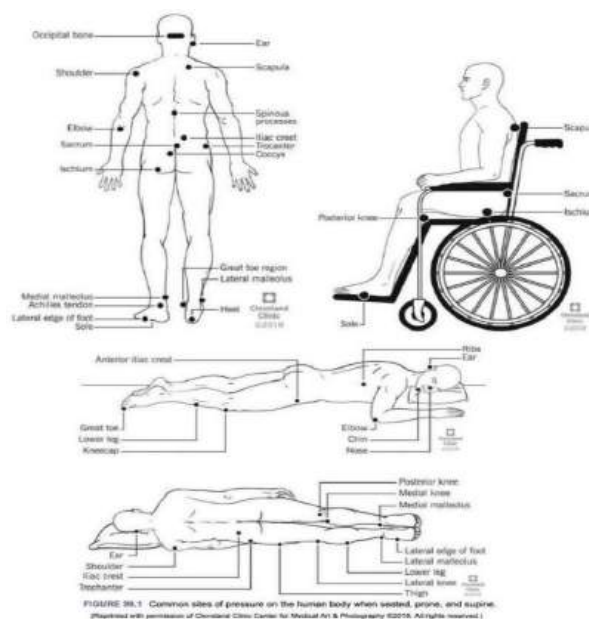
Lapisan kulit yang hilang secara lengkap dengan kerusakan yang luas, kerusakan pada otot, nekrosis jaringan, tendon atau tulang. Terdapat lubang yang dalam serta saluran sinus juga termasuk dalam stadium IV dari luka decubitus (Alzamani et al., 2022).



Gambar 1. Stadium Luka Tekan

2.5 Patofisiologi

Ulkus dekubitus disebabkan oleh beberapa faktor (faktor eksternal dan internal), akan tetapi hampir semua menunjukkan gejala yaitu terjadinya nekrosis dan iskemia. Tekanan mekanis dapat menyebabkan luka dekubitus yang tidak dapat dihilangkan ke jaringan lunak, biasanya paling sering terjadi pada tulang yang menonjol seperti sakrum, ishium, tumit, atau trokanter. Hal ini bisa dilihat pada lokasi ulkus yang terbentuk akibat tekanan, sebagai berikut:



Gambar 2. Lokasi umum penekanan pada tubuh

Ulkus dekubitus terutama disebabkan oleh tekanan konstan selama waktu yang lama, meskipun jaringan kulit dapat menahan tekanan eksternal yang tidak normal. Untuk menghentikan aliran darah, tekanan eksternal harus melebihi tekanan kapiler arteri (32 mmHg) dan lebih besar dari tekanan penutupan kapiler (8–12 mmHg) untuk mencegah kembalinya aliran darah dari vena. Jika tekanan dipertahankan di atas tingkat ini, itu akan menyebabkan iskemia pada jaringan tubuh, yang pada gilirannya akan menyebabkan nekrosis jaringan. Tekanan yang cukup besar ini dapat berasal dari kompresi atau tekanan dari kasur yang keras, pagar tempat tidur rumah sakit, atau permukaan keras yang bersentuhan dengan

pasien. Ulkus, yang terjadi saat tidur, dapat disebabkan oleh gesekan kulit yang memiliki kontak langsung dengan permukaan seperti pakaian atau tempat tidur.

2.6 Pemeriksaan Diagnostik

- 1) Inspeksi meliputi kulit dan otot, seperti turgor kulit, warna, pecah pecah, adanya infeksi dan ulserasi, berkeriat, adanya bula atau kalus, adanya rambut pada kaki, bentuk kuku. Inspeksi pada otot seperti sikap dan postur dari tungkai kaki, deformitas pada kaki membentuk *claw toe* atau *charcot joint*, keterbatasan gerak sendi, tendon, cara berjalan, dan kekuatan kaki.
- 2) Pemeriksaan neurologis dengan monofilament dan tuning fork 128 Hz, sensasi pinprick, dan reflek kaki untuk mengukur sensasi, getaran, dan tekanan.
- 3) Lakukan pemeriksaan aliran darah dengan menggunakan palpasi denyut nadi pada arteri kaki, waktu perebusan kapiler, perubahan warna, atrofi pada kulit dan kuku, dan indeks indeks ankle brachial.
- 4) Status klinis pasien memerlukan pemeriksaan laboratorium, yaitu: pemeriksaan glukosa darah baik glukosa darah puasa atau sewaktu, *glycohemoglobin* (HbA1c), *Complete Blood Count* (CBC), urinalisis, dan lain- lain.
- 5) Pemeriksaan Penunjang: X-ray, EMG (Electromyography) dan pemeriksaan laboratorium untuk mengidentifikasi infeksi dan kuman penyebabnya (Malik, 2018)

2.7 Penatalaksanaan Ulkus Dekubitus

Penatalaksanaan dekubitus menurut Alzamani, *et al.*, (2022) dapat dilakukan dengan:

- a. Mengurangi tekanan lebih besar pada area ulkus
Pengurangan tekanan sangat penting karena ulkus tidak akan sembuh jika tekanan berlebihan berlanjut.
- b. Mempertahankan keadaan bersih pada ulkus dan sekitarnya
Keadaan ini akan menyebabkan penyembuhan luka lebih cepat dan lebih baik. Untuk melakukan ini, kompres, pencucian, pembilasan, pengeringan,

dan pemberian bahan topikal seperti larutan NaC10,9%, larutan H2O2 3%, larutan plasma, dan larutan Burowi, bersama dengan larutan antiseptik lainnya, dapat dilakukan. Pada Stadium I dekubitus, Pranarka (2001) mengatakan bahwa kulit yang tertekan dan kemerahan harus dibersihkan dengan air hangat dan sabun, kemudian diberi lotion dan dipijat dua kali sehari untuk memperlancar sirkulasi dan mencegah iskemia jaringan.

c. Mengangkat jaringan nekrotik

Jika ada jaringan nekrotik pada ulkus, aliran bebas dari bahan yang terinfeksi akan terhambat. Akibatnya, pembentukan jaringan granulasi dan epitelisasi akan terhambat.

d. Mengatasi infeksi

Ulkus yang terinfeksi harus dibersihkan dengan larutan antiseptik seperti larutan H2O2 3%, povidon iodine 1%, dan seng sulfat 0,5% setiap hari.

e. Merangsang dan membantu pembentukan jaringan granulasi dan epitelisasi.

Untuk mencapai hal ini, bahan-bahan topikal seperti salep asam salisilat 2%, preparat seng (Zn O, Zn SO), dan oksigen hiperbarik dapat diberikan. Bahan-bahan ini memiliki sifat bakteriostatik terhadap beberapa bakteri, serta memiliki efek proliferasi epitel, meningkatkan jaringan granulasi, dan meningkatkan kondisi vascular.

f. Tindakan bedah selain untuk pembersihan

ulkus juga diperlukan untuk mempercepat penyembuhan dan penutupan ulkus, terutama ulkus dekubitus stadium III & IV dan karenanya sering dilakukan tandur kulit ataupun myocutaneous flap.

g. Pemberian nutrisi

Mendukung proses penyembuhan luka sangat penting. Harus memenuhi kebutuhan energi harian, protein, cairan, dan mikronutrien (Amirsyah, *et al.*, 2020).

2.8 Komplikasi Ulkus Dekubitus

Komplikasi akibat ulkus dekubitus menurut Zaidi *et al.*, (2024) terdiri dari :

a. Infeksi

Infeksi adalah masalah yang paling umum. Ulkus derajat 3 dan 4

mengancam jiwa dan memerlukan penanganan intensif. Periostitis, osteomielitis, artritis septik, dan pembentukan sinus dapat terjadi jika infeksi menyebar ke jaringan dan tulang yang lebih dalam.

b. Risiko kehilangan cairan

Luka ini bersifat katabolik, menyebabkan kehilangan cairan dan protein yang parah, yang dapat menyebabkan hipoproteinemia atau malnutrisi. Setiap hari, ulkus yang mengeluarkan cairan dapat menghasilkan kehilangan hingga lima puluh gram protein.

c. Anemia

Anemia kronis atau amiloidosis sekunder dapat terjadi akibat ulkus dekubitus kronis. Kehilangan air dan pendarahan kronis juga dapat menyebabkan anemia sekunder.

d. Komplikasi Pasca Operasi

e. Akibat operasi rekonstruksi, dapat terjadi komplikasi sekunder jika perawatan pascaoperasi tidak memadai. Ini termasuk munculnya hematoma atau seroma, penyempitan luka, munculnya abses, atau sepsis pada luka yang telah dilakukan setelah operasi.

2.9 Anatomi Fisiologi

1. Anatomi Kulit

Kulit terdiri dari dua lapisan jaringan: dermis, yang terletak di bawah epidermis, dan epidermis, yang berfungsi sebagai lapisan terluar. Sementara dermis adalah jaringan ikat, epidermis adalah jaringan epitel berlapis gepeng dengan lapisan tanduk. Kulit yang lebih tebal mengurangi risiko cedera dan infeksi dan memberikan tameng yang lebih kuat terhadap ancaman dari luar.

a. Epidermis

Keratinosit adalah sel yang mendominasi lapisan sel epidermis. Epidermis tidak memiliki pembuluh darah karena merupakan jaringan epitel.

b. Dermis

Dermis, jaringan ikat kulit di bawah epidermis, Jaringan ini mempengaruhi seberapa kencang kulit menjadinya. Ini memiliki dua lapisan jaringan ikat: lapisan retikular dan lapisan papilar. Fibroblas, limfosit, dan sel

mast adalah beberapa jenis sel yang ada di dermis. Bagian dermis yang menonjol ke arah dermis disebut papila dermis (rigi dermis), sedangkan rete ridges adalah bagian dermis yang menonjol ke arah dermis.

c. Hipodermis

Lapisan hipodermis di bawah kulit bukan jaringan kulit; itu adalah bagian dari fasia superfisial. Jaringan ikat longgar yang banyak mengandung lemak membentuk jaringan ini.

d. Kulit tipis dan tebal

Dua jenis kulit yang secara kasar menutupi tubuh manusia adalah kulit tipis dan kulit tebal. Kulit tipis menutupi sebagian besar area permukaan tubuh dan memiliki banyak variasi, seperti kulit di sekitar adhi dan di sekitar mata. Area telapak tangan dan kaki memiliki kulit yang tebal dan banyak kelenjar keringat meskipun tidak memiliki folikel rambut.

e. Asesoris kulit

- 1) Kelenjar keringat
- 2) Folikel rambut
- 3) Kelenjar sebacea

2. Fisiologi Kulit

Sering dikaitkan dengan keindahan dan estetika, kulit manusia termasuk organ yang kompleks dan serbaguna. Peran kulit jauh sebenarnya lebih penting daripada penampilannya. Kulit memiliki banyak fungsi karena sifatnya yang fisiologis. Kulit berfungsi sebagai perlindungan tubuh dari bahaya dari luar seperti bakteri, zat kimia, panas, dan sinar ultraviolet. Fungsi kulit tersebut terdiri atas:

a. Pelindung terhadap stres mekanis

Kulit menunjukkan kemampuan beradaptasi yang luar biasa terhadap berbagai tekanan mekanis. Paparan mekanis seperti gesekan dan tekanan, memicu respons seluler pada epidermis maupun dermis yang akhirnya menyebabkan penebalan kulit

b. Pelindung terhadap mikroorganisme

Peptida antimikroba atau dalam Bahasa Inggris disebut antimicrobial peptide yang lazim disingkat AMP adalah molekul alami yang memainkan peran penting dalam kekebalan bawaan.

c. Sintesis Vitamin D

Kulit berfungsi sebagai lokasi utama terjadinya sintesis vitamin D.

d. Pelindung terhadap sinar ultraviolet

Karena kulit selalu terpapar faktor lingkungan, radiasi ultraviolet adalah yang paling umum. Meskipun paparan yang berlebihan dapat menyebabkan stres oksidatif, kerusakan DNA, dan disfungsi seluler, paparan yang berlebihan juga dapat menyebabkan kerusakan DNA.

e. Pencegah evaporasi

Kulit memiliki kemampuan yang luar biasa untuk menghalangi dan membatasi proses penguapan dan evaporasi.

f. Termoregulasi

adalah proses fisiologis untuk menjaga suhu tubuh internal tetap stabil bagi semua makhluk hidup. Kulit mamalia, termasuk manusia, memainkan peran penting dalam mengatur suhu tubuh melalui interaksi yang kompleks antara struktur anatomi, jaras saraf, dan proses biokimia.

g. Reseptor sensasi

Kulit memiliki banyak sensasi, termasuk taktil, suhu, dan nyeri, yang memungkinkan kita menghindari atau mengetahui bahaya.

.

2.10 Proses Penyembuhan Luka

1. Fase Koagulasi dan Inflamasi (0-3 hari).

Koagulasi, respons pertama setelah luka, melibatkan platelet. Vasokonstriksi akan terjadi karena pengeluaran platelet. Tujuan homeostatis adalah untuk mencegah perdarahan lebih lanjut. Setelah luka, fase inflamasi muncul beberapa menit kemudian dan bertahan sekitar tiga hari. Pergerakan leukosit, terutama neutrofil, dimungkinkan oleh fase inflamasi. Selanjutnya, neutrofil membunuh fagosit dan bakteri dan masuk ke matriks fibrin untuk mempersiapkan pembentukan jaringan baru.

2. Fase Proliferasi atau Rekonstruksi (2-24 hari).

Jika tidak ada kontaminasi atau infeksi selama fase inflamasi, penyembuhan masuk ke tahap proliferasi atau rekonstruksi. Fase ini memiliki tujuan utama, yaitu proses granulasi, yang berarti mengisi celah di luka. • Angiogenesis, yang merupakan proses pembentukan kapiler baru. Luka akan merah dan dapat dilihat secara klinis. Fibroplasia dan angiogenesis berkorelasi. Jika tidak ada proses angiogenesis, sel penyembuhan tidak dapat bermigrasi, replikasi, melawan infeksi, dan membuat atau deposit bagian matrik baru. • Proses kontraksi, yang berarti menarik kedua tepi luka dekat satu sama lain. Kontraksi.

3. Fase Remodelling atau Pematangan (24 hari-1tahun).

Pada proses penyembuhan luka, fase ini adalah yang terakhir dan paling lama berlangsung. Sintesis dan degradasi kolagen bekerja sama. Untuk memastikan perbaikan sepanjang garis luka, proteinase menyokong serabut kolagen yang meningkat dan tebal secara bertahap. Matriks terdiri dari kolagen. Serat kolagen menyebar dengan saling terikat dan menyatu dan membantu pemulihan jaringan secara bertahap. Pada titik akhir penyembuhan, parut luka yang matang menjadi 80 persen lebih kuat daripada kulit normal (Aminuddin, M., Sukmana, M., Nopriyanto, D., 2020).

Luka dapat dibagi menjadi dua kategori berdasarkan proses

penyembuhannya: penyembuhan primer, di mana tepi luka dapat menyatu kembali dan permukaannya bersih dan tidak ada jaringan yang hilang. Biasanya terjadi setelah luka sembuh dari dalam ke luar. Penyembuhan sekunder, juga dikenal sebagai penyembuhan dengan tujuan sekunder, dimulai dengan pembentukan jaringan granulasi di sekitar dan di dasar luka. Beberapa jaringan hilang. Penyembuhan utama yang tertunda, atau penyembuhan tertiary, berlangsung lambat, seringkali disertai dengan infeksi, dan membutuhkan penutupan luka secara manual (Abdul Herman Syah Thalib & Leni Widia Ningsih, 2021). Perawatan luka kontemporer berfokus pada mempertahankan kelembapan luka dengan menggunakan bahan seperti hydrogel. Di sisi lain, perawatan luka konvensional sering mengganti kain kasa pembalut luka. Hydrogel melunakkan dan menghancurkan jaringan nekrotik tanpa merusak jaringan sehat. Kemudian terserap ke dalam struktur gel dan terbuang bersama pembalut, meninggalkan luka lembab (Sudarta, 2022).

Penelitian Rizaldi (2019) mendapatkan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Perawatan luka ulkus diabetik dengan metode penyembuhan basah lebih cepat daripada metode penyembuhan kering basah. Ini terlihat dari kondisi luka pada minggu pertama perawatan, yang berwarna slough dan mengalami masalah luka umum seperti nekrotik, slough/infeksi, mudah berdarah, dan maserasi. Perawatan dengan salep epitel zalf luka sebagai pengobatan utama dapat mempercepat penyembuhan ulkus diabetikum. Sejalan dengan penelitian oleh Wahyuni (2021) yang menggunakan teknik moist wound healing pada perawatan luka ulkus decubitus lukanya mengalami regenerasi setelah dilakukan perawatan luka dalam rentang waktu selama 7 hari, karena keadaan luka yang moist atau lembab dapat meningkatkan proses mitosis, meminimalkan rasa sakit dan trauma saat ganti balutan, serta membantu pergerakan sel pada luka, sehingga meningkatkan terjadinya regenerasi sel pada luka

.

2.11 Standar Operasional Prosedur

SOP Perawatan Luka: RSUD Wirahadikusumah (RSUD Sumedang)

	PERAWATAN LUKA INFEKSI		
	No. Dokumen 4451139/Kep/XI/201 7	No. Revisi	Halaman
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan : DIREKTUR Dr. H. Hilman Taufik, Ws, M.Kes	
PENGERTIAN	Mengganti balutan untuk membantu dalam proses penyembuhan luka infeksi		
TUJUAN	Sebagai acuan dalam menyiapkan pasien yang akan dilakukan Tindakan perawatan luka infeksi		
KEBIJAKAN	1. Terselenggaranya Tindakan perawatan luka infeksi secara aman di unit keperawatan RSUD Sumedang 2. Dilakukan sebagai Tindakan keperawatan mandiri		
PROSEDUR	1. Pengkajian a. Mengkaji program/instruksi medik mengenai prosedur rawat luka, tipe balutan dan frekuensi ganti balutan b. Mengkaji type dan lokasi luka c. Mengkaji tingkat nyeri klien dan kapan terakhir mendapat obat penghilang nyeri d. Mengkaji riwayat alergi pada obat atau plester 2. Persiapan alat a. Set ganti balutan steril		

	4. Pinset cirurgis 5. Pinset anatomis 6. Kassa 7. Lidi Kapas b. Kassa steril tambahan atau bantalan penutup sesuai kebutuhan c. Sarung tangan bersih dan sarung tangan steril d. Handuk e. Kapas bulat f. Bethadin g. Bengkok h. Baki tindakan atau troli atau meja dorong i. Perlak/pengalas j. Tempat sampah/kantong kresek
	3. Persiapan Klien a. Jelaskan kepada klien dan keluarga tentang tujuan dan prosedur tindakan yang akan dilakukan b. Lakukan pemenuhan kebutuhan privasi klien c. Atur posisi klien sesuai kebutuhan
	4. Pelaksanaan a. Cuci tangan b. Lakukan identifikasi klien c. Siapkan dan dekatkan alat d. Buka set ganti balutan e. Tambahkan kassa steril dan kapas lidi steril secukupnya ke dalam set ganti balutan f. Gunakan sarung tangan bersih g. Gunakan handuk untuk menutupi daerah privasi klien yang terbuka h. Letakkan perlak pengalas dibawah luka i. Atur posisi yang nyaman dan tepat untuk perawatan luka j. Membuka plester searah tumbuhnya rambut dan membuka balutan dengan hati-hati, masukkan balutan kotor ke dalam kantong

	sampah yang telah disediakan k. Buka sarung tangan bersih dan ganti dengan sarung tangan steril l. Bersihkan luka m. Membersihkan dari arah bagian atas ke bawah di setiap sisi luka dengan arah keluar menjauh dari luka n. Olesi luka dengan bethadin atau obat sesuai keadaan luka mulai sejak dari tengah luka o. Selanjutnya tutup luka dengan kassa steril dan lakukan fiksasi dengan plester pada area pinggiran kassa pembalut p. Tulis tanggal dan waktu pergantian balutan pada plester dan tempelkan pada balutan q. Rapihkan klien dan bereskan alat-alat 5. Evaluasi a. Evaluasi respon klien selama dan setelah prosedur b. Evaluasi kebutuhan frekuensi dan ganti balutan c. Evaluasi adanya tanda-tanda alergi terhadap plester d. Evaluasi adanya tanda-tanda infeksi dan adanya cairan luka dan karakteristiknya 6. Dokumentasi a. Catat lokasi, tipe luka dan konsisi luka b. Catat kondisi luka sebelumnya c. Catat cairan serta obat yang digunakan untuk merawat luka d. Catat respon serta toleransi klien selama dan setelah prosedur
UNIT TERKAIT	Seluruh unit perawatan di RSUD Umar Wirahadikusumah

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah laporan kasus/*case reports*. *Case reports* adalah laporan kasus yang berisi uraian laporan terhadap suatu kasus atau masalah yang disajikan..

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan digunakan pada penelitian ini adalah di RSUD Umar Wirahadikusumah Sumedang.

3.3 Subjek Penelitian

Populasi adalah area generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk dipelajari sebelum membuat kesimpulan (Masturoh & Anggita, 2018). Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pasien dengan ulkus decubitus di RSUD Umar Wirahadikusumah.

Kriteria Inklusi :

- a. Pasien dengan ulkus decubitus
- b. Pasien dengan usia 20 – 70 tahun
- c. Pasien yang dirawat di RSUD Umar Wirahadikusumah

Kriteria Eksklusi :

- a. Pasien yang tidak mengalami ulkus decubitus
- b. Pasien yang mengalami ulkus diabetikum
- c. Pasien dengan usia < 20 Tahun

3.4 Teknik Sampling dan Besar Sampel

Teknik pengambilan sampling yaitu dengan menggunakan *nonprobability sampling*. *Nonprobability sampling* tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap elemen populasi untuk terpilih, Contoh dari *nonprobability sampling*

termasuk *convenience sampling*, *quota sampling*, dan *purposive sampling* (Fachreza, 2024)

3.5 Rancangan/Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian laporan kasus atau *case reports*,).

3.6 Alat dan Bahan Penelitian

Penelitian ini menggunakan alat dan bahan seperti lembar pengkajian pada pasien, lembar sop perawatan luka, alat-alat perawatan luka, alat tulis, *handphone* untuk dokumentasi.

3.7 Cara Kerja Penelitian

Pada penelitian kualitatif, manusia sebagai instrumen utama yang bertujuan untuk bertanya, mendengar, dan mengumpulkan data secara langsung kepada responden. Oleh sebab itu, manusia yang menjadi instrumen disebut pewawancara (Afrizal, 2019).

Selain manusia, alat dan bahan lainnya yang digunakan yaitu pedoman wawancara berbentuk kertas yang terdiri atas beberapa pertanyaan dengan jawaban terbuka dan perekam suara atau perekam gambar menggunakan gawai untuk merekam saat proses wawancara berlangsung (Afrizal, 2019).

Tahapan penelitian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- (1) Melakukan Studi pendahuluan
- (2) *Inform Consent*
- (3) Melakukan uji etik
- (4) Melaksanakan Wawancara
- (5) Melakukan Observasi
- (6) Evaluasi dan analisis data
- (7) Pelaporan

3.8 Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan harus segera dianalisis, sehingga peneliti mampu mengetahui data yang kurang dan perlu dilengkapi kembali, terdapat beberapa langkah dalam menganalisis data, antara lain:

- (1) Pengelompokkan data
- (2) Membaca dan menyeluruh
- (3) Memberikan kode pada data-data penting
- (4) Memberikan penjabaran penjelasan tentang kasus dan topik penelitian
- (5) Menetapkan pola
- (6) Mencari hubungan dengan kategori
- (7) Tafsirkan hasil olahan data
- (8) Menyajikan data secara naratif.

3.9 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Waktu Penelitian/Minggu							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Penyusunan proposal								
2.	Revisi proposal								
3.	Perizinan penelitian								
4.	Persiapan penelitian								
5.	Pelaksanaan penelitian								
6.	Pengolahan data								
7.	Penyusunan laporan								
8.	Seminar hasil								
9.	Revisi laporan								
10.	Publikasi laporan								

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Herman Syah Thalib, & Leni Widia Ningsih. (2021). Efektifitas Perawatan Luka Decubitus Dengan Metode Modern Dressing Terhadap Proses Penyembuhan Luka : Literatur Review. *Jurnal Mitrasthat*, 11(1), 37–44. <https://doi.org/10.51171/jms.v11i1.283>
- Afrizal. (2017). Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu (4th ed.). Rajawali Pers.
- Alzamani, L. M. H. I., Marbun, M. R. Y., Purwanti, M. E., Salsabilla, R., & Rahmah, S. (2022). Ulkus Kronis: Mengenali Ulkus Dekubitus dan Ulkus Diabetikum. *Jurnal Syntax Fusion*, 2(02), 272-286.
- Aminuddin, M., Sukmana, M., Nopriyanto, D., & S. (2020). Manajemen Luka Akut Dan Kronik. In *Modul Perawatan Luka* (Vol. 1, Issue perawatan luka). <https://jurnal.poltekkespalembang.ac.id/index.php/jkm/article/download/987/413/>
- Boyko, T. V., Longaker, M. T., & Yang, G. P. (2018). Review of the Current Management of Pressure Ulcers. *Advances in wound care*, 7(2), 57–67. <https://doi.org/10.1089/wound.2016.0697>
- D'Angelo, A., & Sapigni, A. (2021). The use of biodegradable materials in modern wound dressings: A review. *Materials Science and Engineering*, 35(4), 112-118. <https://doi.org/10.1016/j.mse.2021.110078>
- Fachreza, K. A., Harvian, M., Zahra, N., Islam, M. I., Daffa, M., & Wardiyah, M. L. (2024). Analisis Komparatif Antara Probability Dan Nonprobability Dalam Penelitian Pemasaran. *Jurnal Pajak Dan Analisis Ekonomi Syariah*, 1(3), 108-20.
- Hutagalung, M. siregar. (2021). Luka tekan pada pasien stroke dan manfaat aspirin bagi pasien stroke iskemik.
- Ilkafah. (2021). Factors related to the implementation of nursing care ethical principles in Indonesia. *Journal of Public Health Research*, 10(2), 77-88. <https://doi.org/10.4081/jphr.2021.2211>
- Johnson, P. D., & Lucas, A. M. (2018). Skin reactions to adhesive tapes in nursing care: Prevention and management. *Journal of Wound Care*, 27(2), 56-62. <https://doi.org/10.12968/jowc.2018.27.2.56>
- Johnson, P. L., & White, D. T. (2019). Comparative study of alcohol and saline solutions in wound cleansing. *International Journal of Nursing Studies*, 56(3), 150-155. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2019.03.150>
- Kirani, D. C. (2024). Analisis Asuhan Keperawatan Melalui Intervensi Terapi Penggunaan Polyurethane Foam Sebagai Secondary Dressing Pada Fase Proliferasi Pada Ny. M Dan Ny. S Dengan Pressure Injury Di Wocare Center Kota Bogor (Doctoral dissertation, Universitas Nasional). <https://doi.org/10.33024/mnj.v7i5.5752>
- Kottner, J., & Blume-Peytavi, U. (2020). Modern dressings in wound care: Current

- practice and future perspectives. *Wound Medicine*, 28, 100183. <https://doi.org/10.1016/j.wndm.2020.100183>
- Lewis III, J. L. (2023). *Hypercalcemia - Endocrine and Metabolic Disorders - MSD Manual Professional Edition. MDS Manual*. https://www.msdmanuals.com/professional/endocrine-and-metabolic-disorders/electrolyte-disorders/hypercalcemia#Etiology_v8376121
- Mahmuda, I. N. N. (2019). Pencegahan dan tatalaksana dekubitus pada geriatri. *Biomedika*, 11(1), 11-17
- MALIK, R. H. A. (2018). *ULKUS DIABETIKUM*
- Marisi, E. L. D., & Mataputun, D. R. (2022). Efektivitas Modern Dressing dalam Proses Penyembuhan Luka Kronis pada Lansia. *Jurnal Penelitian Kesehatan "SUARA FORIKES" (Journal of Health Research "Forikes Voice")*, 13(3), 720-723. <http://dx.doi.org/10.33846/sf13329>
- McCulloch, J., & Pritchard, A. (2021). The efficacy of advanced dressings in managing pain in patients with chronic wounds. *International Wound Journal*, 18(1), 1-10. <https://doi.org/10.1111/iwj.13424>
- Nur Azizah, T. (2020). *Asuhan keperawatan pada lansia dengan Masalah Keperawatan Resiko Dekubitus di UPT. PSTW Kabupaten Magetan* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo)
- Ousey, K., & Atkinson, R. A. (2019). The role of modern dressings in wound infection management. *British Journal of Nursing*, 28(9), 546-552. <https://doi.org/10.12968/bjon.2019.28.9.546>
- Ousey, K., & Jones, M. (2019). Antimicrobial wound dressings: A systematic review. *Journal of Wound Care*, 28(10), 661-667. <https://doi.org/10.12968/jowc.2019.28.10.661>
- PERKENI. (2019). *Pedoman Pengelolaan Dan Pencegahan Diabetes Melitus Tipe 2 Dewasa Indonesia 2019*. In *Perkumpulan Endokrinologi Indonesia*. PBPERKENI. <https://pbperkeni.or.id/wp-content/uploads/2020/07/PedomanPengelolaan-DM-Tipe-2-Dewasa-di-Indonesia-eBook-PDF-1.pdf>
- Purnama, P. (2022). Proses Penyembuhan dan Perawatan Luka: Review Sistematis. *Farmaka*, 20(1), 23-32. <https://doi.org/10.24156/farmaka.v20i1.1674>
- Rusdi, M. S. (2020). Hipoglikemia Pada Pasien Diabetes Melitus. *Journal Syifa Sciences And Clinical Research (JSSCR)*, 2(2), 83-90.
- Sabbrina, O. N., & Khamid, A. (2022). Perbedaan Hidrokolid dan Minyak zaitun Terhadap Luka Tekan pada Pasien Pressure Ulcers di RSUD Kabupaten Bekasi. *Malahayati Nursing Journal*, 4(9), 2223-2232.
- Smith, J., & Roberts, A. (2020). Effectiveness of alcohol swabs versus normal saline in wound cleaning. *Journal of Wound Care*, 29(5), 220-225. <https://doi.org/10.12968/jowc.2020.29.5.220>
- SNARS (2018) 'Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit', Available at: <https://doi.org/362.11..>
- Sri, M. (2022). *Asuhan Keperawatan Medikal Bedah Pada Ny. D dengan Ulkus*

- Dekubitus Di Ruang PAV 2 RS Darmo Surabaya* (Doctoral dissertation, STIKES HANG TUAH SURABAYA).
- Sriwiyati, L., & Kristanto, B. (2020). Karakteristik Luka dan Penggunaan Balutan Luka Modern. *Adi Husada Nursing Journal*, Vol 6 No 1.
- Sudarta. (2022). *ulkus dekubitus*. 16(1), 1–23.
- Thalib, A. H., & Ningsih, L. W. (2021). Efektifitas Perawatan Luka Decubitus Dengan Metode Modern Dressing. *Jurnal Mitrasehat*, Volume XI Nomor 1.
- Xu, Y., & Zhang, C. (2022). Smart wound dressings: The future of wound care. *Advanced Healthcare Materials*, 11(7), 2101793. <https://doi.org/10.1002/adhm.202101793>
- Zaidi SRH, Sharma S. Pressure Ulcer. [Updated 2024 Jan 3]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan-. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK553107/>

Informed consent

Lembar Penjelasan Penelitian

Nama Peneliti : Ayu Andini Triana

NIM : 2411428

Alamat : Desa Cikahuripan RT 19 RW 08, Klapanunggal, Bogor, Jawa Barat

Judul Penelitian : ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN ULKUS DEKUBITUS DENGAN PENERAPAN HYDROGEL DALAM PROSES PENYEMBUHAN LUKA DI RSUD UMAR WIRAHADIKUSUMAH

Peneliti adalah mahasiswa Program Studi Profesi Ners Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Sumedang. Saudara telah diminta untuk ikut berpartisipasi dalam penelitian ini. Responden dalam penelitian ini dilakukan sukarela. Saudara memiliki hak untuk menolak berpartisipasi dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan cara penerapan hydrogel untuk membantu proses penyembuhan luka dekubitus. Segala informasi yang saudara berikan akan digunakan sepenuhnya hanya dalam penelitian ini. Peneliti sepenuhnya akan menjaga kerahasiaan identitas saudara dan tidak dipublikasikan dalam bentuk apapun. Jika ada yang belum jelas, saudara boleh bertanya pada peneliti. Jika saudara sudah memahami penjelasan ini dan bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini, silahkan saudara menandatangani lembar persetujuan yang akan dilampirkan.

Peneliti

Ayu Andini Triana

Lembar Persetujuan Responden (Informed Consent)

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Umur :

Alamat :

Menyatakan bersedia menjadi responden pada penelitian yang di lakukan oleh :

Nama Peneliti : Ayu Andini Triana

NIM : 2411428

Alamat : Desa Cikahuripan RT 19 RW 08, Klapanunggal, Bogor, Jawa Barat

Judul Penelitian : ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN ULKUS DEKUBITUS
DENGAN PENERAPAN HYDROGEL DALAM PROSES PENYEMBUHAN LUKA DI
RSUD UMAR WIRAHADIKUSUMAH

Saya akan bersedia untuk dilakukan intervensi dan perawatan luka demi kepentingan penelitian. Dengan ketentuan, hasil penelitian akan dirahasiakan dan hanya semata-mata untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Demikian surat pernyataan ini saya sampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumedang,.....

Responden

(.....)

DAFTAR NAMA TIM PENELITIAN

1. AYU ANDINI TRIANA
2. POPI SOPIAH



Ayu Andini Triana

+6281-8640-8611 · ayuandini2511@gmail.com · @ayuandinitrn_ linkedin.com/in/ayuandinitrn

TENTANG SAYA

Saya seorang Mahasiswa Profesi Ners di Universitas Pendidikan Indonesia dengan Program Studi Profesi Ners. Saya juga merupakan lulusan baru di Universitas Pendidikan Indonesia dengan Program Studi S1 Keperawatan dengan meraih IPK 3.74 (cumlaude). Saya seorang yang pekerja keras dan dapat diandalkan, mampu bekerja dengan tim secara kreatif, bekerja sesuai target dan akan selalu tercapai tepat waktu dengan kemampuan terbaik saya.

KOMPETENSI

Berkomunikasi yang baik Manajemen waktu Keahlian dalam berorganisasi	Mampu melakukan kompetensi keperawatan seperti pemenuhan kebutuhan dasar manusia serta tindakan invasif	Andal dan dapat diandalkan serta mampu belajar dan beradaptasi dengan cepat
--	---	---

PENGALAMAN

RSUD SUMEDANG

November 2023 - Januari 2024

Perawat

Memberikan Asuhan keperawatan kepada pasien yang sesuai dengan kebutuhannya, Melakukan beberapa tindakan keperawatan seperti pemasangan infus, pengambilan darah, membantu personal hygiene, EKG, Infus Pump, Kebutuhan eliminasi, dll

PUSKESMAS SITU SUMEDANG

Oktober 2023 - November 2023

Perawat, Registrasi, Vaksinator

Membantu proses registrasi pasien, menginput data pasien baik umum dan BPJS, Memberikan Asuhan keperawatan kepada pasien yang sesuai dengan kebutuhannya, Melakukan beberapa tindakan keperawatan seperti pemasangan infus, pengambilan darah, membantu personal hygiene, EKG, Infus Pump, Kebutuhan eliminasi, dll

KONI SUMEDANG

Maret 2022

Relawan Tenaga Medis

Membantu dokter untuk melakukan pemeriksaan kesehatan kepada atlet yang akan melakukan perlombaan, saya melakukan pengkajian, pemeriksaan fisik, pemeriksaan tanda-tanda vital, dan membantu dokter saat ada atlet yang mengalami cedera.

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA & PUSKESMAS TANJUNGSARI

September 2021

Asisten Vaksinasi

Membantu perawat dan bidang yang melakukan vaksinasi. Saya mampu memberikan vaksin covid-19 kepada klien, melakukan tanda-tanda vital, dan memberikan penyuluhan

PUSKESMAS TANJUNGSARI

Agustus-September 2021

Asisten Keperawatan, Registrasi, Vaksinator

Membantu proses registrasi pasien, menginput data pasien baik umum dan BPJS, Memberikan Asuhan keperawatan kepada pasien yang sesuai dengan kebutuhannya, Melakukan beberapa tindakan keperawatan seperti pemasangan infus, pengambilan darah, membantu personal hygiene, dll

KLINIK DR. BETTY

Juni 2019

Asisten Keperawatan, Registrasi

Membantu proses registrasi pasien, menginput data pasien baik umum dan BPJS, Memberikan Asuhan keperawatan kepada pasien yang sesuai dengan kebutuhannya, Melakukan beberapa tindakan keperawatan seperti pemasangan infus, pengambilan darah, membantu personal hygiene, dll

KLINIK DR. ANGGI KLAPANUNGGAL

November-Desember 2019

Asisten Keperawatan, Registrasi

Membantu proses registrasi pasien, menginput data pasien baik umum dan BPJS, Memberikan Asuhan keperawatan kepada pasien yang sesuai dengan kebutuhannya, Melakukan beberapa tindakan keperawatan seperti pemasangan infus, pengambilan darah, membantu personal hygiene, dll

RSAD RIDWAN MEURAKSA JAKARTA TIMUR

April 2019

Asisten Keperawatan

Memberikan Asuhan keperawatan kepada pasien yang sesuai dengan kebutuhannya, Melakukan beberapa tindakan keperawatan seperti pemasangan infus, pengambilan darah, membantu personal hygiene, dll

PENGALAMAN ORGANISASI

OSIS SMK FARMASI AVICENNA CILEUNGSI Sekretaris	2019-2020
HIMPUNAN MAHASISWA NERS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Wakil Ketua	2021-2022
PROGRAM TUTORIAL UPI KAMPUS SUMEDANG Staff Muktimedia	2021-2022
HIMPUNAN MAHASISWA NERS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Wakil Ketua	2022-2023
PROTOKOL BUMI SILIWANGI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Bidang Penugasan	2021-2024
BEM UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA KAMPUS SUMEDANG Sekretaris Departemen Komunikasi dan Informasi	2021-2022
BEM REMA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Staff Administrasi	2022-2023
BEM UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA KAMPUS SUMEDANG Sekretaris Umum	2023-2024

PENDIDIKAN

SMK FARMASI AVICENNA CILEUNGSI Asisten Keperawatan	2018-2020
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Keperawatan - S1	2020-2024
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Pendidikan Profesi Ners	2024-Sekarang

KEMAMPUAN

Microsoft Office Microsoft Office Word Microsoft Office Excel Microsoft Office Power Point
Public Speaking Berkomunikasi di depan publik Menjadi MC dalam berbagai kegiatan/event
Design and Editor Design dan edit menggunakan aplikasi Canva, Capcut, Video Editor, Adobe Photoshop, dll

PELATIHAN

Microsoft Office	2023
Basic Training Cardiac Life Support	2024

PUBLIKASI

HUBUNGAN FUNGSI KEPEMIMPINAN KEPALA RUANGAN SEBAGAI PENGARAH KINERJA PERAWAT DALAM PEMBERIAN ASUHAN KEPERAWATAN: SYSTEMATIC REVIEW	2024
THE EFFECTIVENESS OF GIVING DATES AGAINST INCREASED HEMOGLOBIN LEVELS IN ANEMIC ADOLESCENT GIRL: SYSTEMATIC REVIEW	2024
PENYULUHAN KESEHATAN KEPADA IBU MENYUSUI MENGENAI GIZI SEIMBANG UNTUK MENCEGAH TERJADINYA STUNTING	2023

Lampiran 5 Riwayat Hidup Peneliti

1. Nama : Popi Sopiah
2. NIP. : 197810072006042011
3. Pangkat/Jabatan/Gol. : Penata/Lektor/III-d
4. Instansi : Universitas Pendidikan Indonesia KD-Sumedang
5. Tempat/Tanggal Lahir : Sumedang/7 Oktober 1978
6. Alamat :

Ds. Citimun Rt 003 Rw. 002 No.48
Kec. Cimalaka
Kab. Sumedang-Provinsi Jawa Barat

7. No. Telp/ HP : 082115096951

8. Riwayat Pendidikan :

No	Universitas	Kota/Negara	Tahun Lulus	Departemen
1	Universitas Padjadjaran	Bandung/Indonesia	2003	Ilmu Keperawatan
2	Universitas Indonesia	Jakarta/Indonesia	2017	Ilmu Biomedik

9. Riwayat Pekerjaan :

NO .	DINAS / INSTANSI	JABATAN	ATASAN LANGSUNG	KET.
1 .	Akademi Keperawatan (Akper) Pemerintah Kabupaten Sumedang	Dosen	Hj. Mimin Rosmini, Dra., SKM., M.Kes.	2003-2011
2 .	Akademi Keperawatan (Akper) Pemerintah Kabupaten Sumedang	Dosen	Drs. H. Dadang Rukmawan, M.Kes.	2012-2017
3 .	UPI Kampus Sumedang	Dosen	Prof. Dr. Herman Subarjah, M.Si Prof. Dr. Yudha Munajat Saputra, M.Ed. Dr. Indra Safari, MPd	2017- 2020 2021- 2 Januari 2025 3 Januari 2025 - sekarang

10. Pengalaman Penelitian:

Nama Proyek	Pemberi Dana	Judul Penelitian	Jabatan (ketua/anggota)	Besar dana (Rp.)	Tahun
Mandiri	Mandiri	Pengaruh Pendidikan Kesehatan terhadap Tingkat Pengetahuan Ibu Post Partum Primipara di Ruang Dahlia RSUD Sumedang Tahun 2003	Ketua	-	2003
Mandiri	Mandiri	Kualitas Hidup pasien Stroke berdasarkan karakteristik penderita di Ruang Rawat Inap RSUD Sumedang pada Tahun 2011	Ketua	-	2011
Mandiri	Mandiri	Pengetahuan Perawat dalam Melaksanakan Pemberian Terapi Obat di Ruang Penyakit Dalam Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012	Anggota	-	2012
Hibah PITTA	Universitas Indonesia	Mekanisme Regulasi Inflamasi Pada Endometriosis Yang Diberikan Asam Galat Secara In Vitro	Anggota	90.000.000	2016
Hibah Prodi	Universitas Pendidikan Indonesia	Karakteristik Perawat sebagai pendidik klinik keperawatan (clinical	anggota	5.625.000	2019

		instructor) dan perawat klinis di RSUD Sumedang, Puskesmas cimilaka dan Puskesmas Paseh			
Hibah Prodi	Universitas Pendidikan Indonesia	Hubungan kecemasan dengan pencapaian target kompetensi klinik keperawatan dasar pada mahasiswa tingkat II prodi keperawatan	anggota	5.625.000	2019
Hibah Litabmas UPI	Universitas Pendidikan Indonesia	Hubungan status nutrisi (IMT) dan kolesterol darah dengan kejadian hipertensi pada lansia	Ketua	25.000.000	2020
Hibah Kamda UPI	Universitas Pendidikan Indonesia	Profil <i>hypertension selfcare</i> lansia penderita hipertensi dengan hiperkolesterol di masa pandemik COVID-19	Ketua	17.500.000	2021
Hibah Kamda UPI	Universitas Pendidikan Indonesia	Persepsi dan Kesiapan Dosen Keperawatan tentang Interprofession al Education dalam Pendidikan Keperawatan pada Masa Pandemi	Anggota	17.500.000	2021
Hibah Kamda UPI	Universitas Pendidikan Indonesia	Indonesian Herbal Medicine sebagai Upaya	Ketua	17.500.000	2022

		penurun tekanan darah pada penderita Hipertensi : Studi Bibliometrik			
Hibah Kamda UPI	Universitas Pendidikan Indonesia	Efektifitas terapi senyum dan dzikir terhadap tekanan darah pada penderita Hipertensi : Studi Literatur	Ketua	10.000.000	2023
Hibah LPPM UPI	Universitas Pendidikan Indonesia	Hubungan antara Literasi Kesehatan dengan profil aset kesehatan anak usia sekolah	Anggota	20.000.000	2023
Hibah LPPM UPI	Universitas Pendidikan Indonesia	Pengaruh pendidikan kesehatan terhadap literasi kesehatan, emosi, dan coping siswa Sekolah Dasar: Pre Experimental Design	Anggota	25.000.000	2024

11. Pengalaman Pengabdian

Nama Proyek	Pemberi Dana	Judul pengabdian	Jabatan (ketua/anggota)	Besar dana (Rp.)	Tahun
Litabmas UPI	UPI Non PNPB	Peningkatan kesadaran remaja tentang kesehatan reproduksi melalui model pendampingan teman sebaya di kecamatan cimilaka sumedang	anggota	40.000.000	2018
Litabmas UPI	UPI Non PNPB	Peningkatan kesehatan Jiwa Masyarakat melalui pembentukan	anggota	40.000.000	2019

		desa siaga sehat jiwa			
Hibah Kamda (Prodi)	UPI	Peningkatan pengetahuan tentang perawatan menarke pada anak usia sekolah dasar (10-12) tahun melalui media audiovisual	Ketua	6.075.000	2019
Hibah Kamda (Prodi)	UPI	Peningkatan kemampuan keluarga dalam merawat klien dengan gangguan jiwa melalui family psikoedukasi therapy di desa licin kecamatan cimalaka sumedang	anggota	6.075.000	2019
Litabmas UPI	UPI Non PNPB	Peningkatan Kesehatan Jiwa Masyarakat Melalui Pembentukan Desa Siaga Sehat Jiwa (DSSJ) di wilayah Puskesmas Cimalaka	Anggota	30.000.000	2019
Mandiri	-	Pemeriksaan dini kesehatan lansia, screening hipertensi dan kolesterol darah lansia di wilayah kerja PKM Cimalaka	Ketua	-	2020
Hibah Kamda (Prodi)	UPI	Penguatan Protokol Kesehatan COVID-19 Menjelang Pembelajaran Tatap Muka	Anggota	15.000.000	2021

		Sekolah Dasar (SD) se-Kecamatan Cimalaka			
Hibah Kamda UPI	Universitas Pendidikan Indonesia	Optimalisasi program UKS untuk mengurangi resiko penyebaran COVID-19 (Pengembangan Model UKS Partisipatif)	Anggota	15.000.000	2022
Hibah PKM Dana universitas	Universitas Pendidikan Indonesia	Optimalisasi Kemampuan Perawat Community Mental Health Nursing (CMHN) dalam Manajemen Asuhan Keperawatan Psikososial masyarakat pada masa pandemic COVID-19 di Kabupaten Sumedang	Anggota	27.000.000	2022
Hibah Kamda UPI	Universitas Pendidikan Indonesia	Pembentukan Supportif Group Keluarga Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam Program Rehabilitasi di Puskesmas Sukagalih	Anggota	10.000.000	2023
Litabmas UPI	UPI Non PNPB	Peningkatan Kesehatan Jiwa Siswa Melalui Program Sekolah Sehat Jiwa (Sejiwa)	Anggota	40.000.000	2024

12. Publikasi Ilmiah:

No.	Nama-nama penulis	Judul tulisan	Nama seminar/jurnal	Kota	Bulan,tahun
-----	-------------------	---------------	---------------------	------	-------------

1	A Bustami, SSK Nareswari, PP Sopiah, MA Zoya, A Ade, R Muharram	Cell Viability Inhibition Effect of Gallic Acid and Its Synthetic Derivative Forms on Primary Cultured Endometriosis Cells	Advanced Science Letters 23 (7), 6681-6684	Amerika	Juli, 2017
2	A Bustami, H Dachniar, ZM Adyasa, SSK Nareswari, P Sopiah, A Arsianti, R Muharam	The Apoptotic Effect of Gallic Acid and Its Derivatives on Primary Cultured Endometriosis Cells	Advanced Science Letters 23 (7), 6697-6700	Amerika	Juli, 2017
3	Arleni Bustami, Popi Sopiah, R.Muharam, Heri Wibowo, Ade Arsianti	The Effect of Gallic Acid and Its Derivatives form on TNF-a cytokines and viability of Endometriosis Cells in vitro	Seminar Internasional ICOLIB 2017 Prosiding 0-387-95457-0	Jember, Indonesia	Agustus, 2017
4	Arleni Bustami, Popi Sopiah, R.Muharam, Heri Wibowo	Effect of Gallic Acid and Its Derivatives On inflammatory regulation of endometriotic primary culture : study of NfKB mRNA expression and IL-6 secretion	<i>Biomedical & Pharmacology Journal</i> , Vol. 11 (3), p. 1479-1484 http://biomedpharmajournal.org/vol11no3	Indonesia	2017
5	Sri Wulan Lindasari, Reni Nuryani, Popi Sopiah	Hubungan kecemasan dengan pencapaian target kompetensi praktek klinik keperawatan dasar mahasiswa prodi keperawatan UPI kampus Sumedang	Syntax Literate, volume 5 Nomor 1 Januari 2020 ISSN : Print 2541-0849 online 2548-1398	Cirebon Indonesia	2019
6	Reni Nuryani, Sri Wulan Lindasari, Popi Sopiah	Upaya peningkatan kesehatan jiwa masyarakat melalui pembentukan desa siaga sehat jiwa (DSSJ)	Syntax Literate, volume 5 Nomor 4 April 2020	Cirebon Indonesia	2020

7	Popi Sopiah, Popon Haryeti, Dedah Ningrum	Correlation of bmi and cholesterol levels with hypertension in the elderly	Eurasian Journal of Biosciences, 2020 - Volume 14 Issue 2, pp. 6533-6539 http://www.ejournals.org/article/correlation-of-bmi-and-cholesterol-levels-with-hypertension-in-the-elderly-8402#	Turkey	December, 2020
8	Popi Sopiah, Popon Haryeti, Nunung Siti Sukaesih, Reni Nuryani, Sri Wulan Lindasari	Total Cholesterol Levels and degrees of hypertension in the elderly	Journal of Nursing Care, Volume 4 Issue 1 February 2021 ISSN : 2614-1698 Page : 295-301 http://jurnal.unpad.ac.id/jnc/article/view/29756	FIK UNPAD, Bandung Indonesia	February 2021
9	Nunung Siti Sukaesih, Hikmat Pramajati, Sri Wulan Lindasari, Emi Lindayani, Dewi Dolifah, Popi Sopiah	Mental Health Children during Pandemic Covid 19: A Bibliometric Study	Journal of Nursing Care 4 (3) 233-243 2021 https://journal.unpad.ac.id/jnc/article/view/30771	FIK UNPAD, Bandung Indonesia	Oktober 2021
10	R Nuryani, SW Lindasari, P Sopiah, DY Rahmat, PM Nurhuda	Optimalisasi Kemampuan Perawat Community Mental Health Nursing dalam Manajemen Asuhan Keperawatan Psikososial pada Masa Pandemi COVID-19 di Kabupaten Sumedang	PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat 7 (6), 868-874, 2022	LPPM Universitas Muhammadiyah Palangkaraya	Nopember 2022
11	P Sopiah, NS Sukaesih, R Nuryani, P Haryeti, SW Lindasari	Enhancing Teenagers' knowledge About Menarche Care In Elementary School Age Through Audiovisual Media	Martabe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 5 (5), 1970-1977	LP2M Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan	Agustus 2022

12	NS Sukaesih, P Sopiah, SW Lindasari, E Lindayanti, H Pramajati, Irawan Danismaya, Burdahyat Burdahyat	Perception and Readiness of Nursing Lecturers on Interprofessional Education	Jurnal Keperawatan Soedirman 17 (2), 50-56, 2022	Universitas Jenderal Soedirman	Juli 2022
13	R Nuryani, D Dolifah, APK Astuti, P Sopiah, SW Lindasari	Optimalisasi Peran Perawat Puskesmas Dalam Pelayanan Keperawatan Kesehatan Jiwa Pada Masa Pandemi Covid 19 Melalui Program Pelatihan Community Mental Health Nursing (Cmhn)	Martabe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 5 (4), 1276-1285, 2022 http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/martabe/article/view/5441	LP2M Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan	Juli 2022
14	NS Sukaesih, AP Hudaya, H Pramajati, P Sopiah, E Lindayani	Penguatan protokol kesehatan COVID-19 menjelang pembelajaran tatap muka sekolah dasar (SD) pada guru se- Kecamatan Cimalaka	Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 7 (2), 469-482, 2022	LPPM UNMA	Mei 2022
15	Popi Sopiah, Novita Alviani, Heri Ridwan, Sri Wulan Lindasari, Reni Nuryani	Nursing Student's Anxiety About Career During the Pandemic Covid-19	https://medic.upm.edu.my/upload/dokumen/2022022317223113_0944.pdf Malaysian Journal of Medicine and Health Sciences, 18 (2022) 65-69 (eISSN 2636-9346)	Universitas Putra Malaysia	Februari 2022
16	NS Sukaesih, P Sopiah, E Lindayani, SWL Sari, H Pramajati, D Dolifah,	Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19: Health promotion school (HPS) in preventing the spread of COVID-19	PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat 8 (1), 88-95, 2023	LPPM Universitas Muhammadiyah Palangkaraya	Januari 2023

17	N Setiawati, P Sopiah, P Haryeti	Pengaruh jus jambu biji merah dalam meningkatkan kadar hemoglobin dengan anemia pada remaja putri : literatur review	Jurnal Ners 7 (1), 543-550, 2023 https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/ners/article/view/13619	Universitas Pahlawan	April 2023
18	NND Septiani, P Sopiah, H Ridwan	Dampak sosial dan emosional pada keluarga bayi dengan down syndrom	Jurnal Kesehatan Al-Irsyad 16 (2), 120-127, 2023. https://ejurnal.universitاسالirsyad.ac.id/index.php/jka/article/view/549	STIKES Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap of Central Java Province	Desember 2023
19	S Shalawati, P Sopiah, H Ridwan	Pengaruh status gizi terhadap kejadian penyakit tuberkulosis paru: literature review	Jurnal Kesehatan Al-Irsyad 16 (2), 107-119 https://ejurnal.universitاسالirsyad.ac.id/index.php/jka/article/view/552	STIKES Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap of Central Java Province	Desember 2023
20	R Nuryani, D Dolifah, P Sopiah, A Faozi, A Purnama	Pembentukan Supportif Group Keluarga Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam Program Rehabilitasi di Puskesmas Sukagalih	Jurnal Peduli Masyarakat 5 (4), 1127-1134, 2023 https://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/JPM/article/view/2325	Global Health Science Group	Desember 2023
21	IY Sari, P Sopiah, H Ridwan	Patologi dan patofisiologi penyakit autoimun: inflammatory bowel disease: Pathology and Pathophysiology of Autoimmunity Disease: Inflammatory Bowel Disease	Jurnal Ilmiah Keperawatan (Scientific Journal of Nursing) 9 (5), 587-593		Oktober 2023

22	T Rizki, D Ningrum, APK Astuti, P Sopiah	Gambaran Pengetahuan Tentang Perilaku CERDIK Pada Wanita Menopause Yang Menderita Hipertensi	Jurnal Ners 7 (2), 1476-1483 https://journal.univ-ersitaspahlawan.ac.id/index.php/ners/article/view/15638	Fakultas Ilmu Kesehatan (FIK) Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai	Oktober 2023
23	R Nuryani, SW Lindasari, P Sopiah, H Pramajati, PM Nurhuda	Readiness Of Community Health Centers Nurse In Implementing Psychosocial Nursing Care During The COVID-19 Pandemic	Jurnal Keperawatan Muhammadiyah 8 (3)2023 https://journal.um-surabaya.ac.id/JKM/article/view/15308	Universitas Muhammadiyah Surabaya	Juli, 2023
24	NS Sukaesih, AP Hudaya, D Ningrum, H Pramajati, P Sopiah,	Face-to-face classes during COVID-19: implementation of school health protocols	Enfermería Global 22 (3), 309-332, 2023 https://revistas.um.es/eglobal/article/view/554501	Universidad de Murcia	Juli, 2023
25	FN Septiani, P Sopiah, H Ridwan	Literatur Review: Hubungan Suplementasi Vitamin A Dengan Infeksi Virus Campak:	Jurnal Ilmiah Keperawatan (Scientific Journal of Nursing) 9 (2), 303-310 2023 https://www.journal.stikespemkabjombang.ac.id/index.php/jikep/article/view/1515	Stikes Pemkab Jombang	Juni, 2023
26	D Herawati, DN Azzahra, HD Farhah, JCH Hadi, JT Sagala, NC Rosadi. P Sopiah, H Ridwan	Efek Samping Penggunaan Antibiotik Irasional Pada Gangguan Pernapasan Infeksi Saluran Pernafasan Akut	Jurnal Ilmiah Keperawatan (Scientific Journal of Nursing) 9 (2), 464-47 2023	Stikes Pemkab Jombang	Juni, 2023
27	S Nurhalimah , P Sopiah, H Ridwan	Hubungan Kekurangan Asam Folat Ibu Hamil Dengan Risiko Terjadinya Spina Bifida Pada Bayi	Jurnal Ilmiah Keperawatan (Scientific Journal of Nursing) 9 (2), 311-315 https://journal.stikespemkabjombang.ac.id/index.php/jikep/article/view/1481	Stikes Pemkab Jombang	Juni, 2023

28	AKZ Putri, P Sopiah, H Ridwan	Modifikasi gaya hidup dan kajian pengobatan pada penderita gastroesophageal reflux disease (gerd)	Jurnal Ilmiah Keperawatan (Scientific Journal of Nursing) 9 (2), 333-34 2023 https://journal.stikespembangkabjombang.ac.id/index.php/jikep/article/view/1499	Stikes Pemkab Jombang	Juni, 2023
29	IS Sa'adah, P Sopiah, H Ridwan	Literatur review: herpes zoster (infeksi lanjutan dari virus varicella zoster)	Jurnal Ilmiah Keperawatan (Scientific Journal of Nursing) 9 (2), 324-323 2023 https://journal.stikespembangkabjombang.ac.id/index.php/jikep/article/view/1512	Stikes Pemkab Jombang	Juni, 2023
30	ANA Muniifah, P Sopiah, H Ridwan	Literature review: faktor penyebab terjadinya pneumonia pada balita (bayi dibawah lima tahun)	Jurnal Ilmiah Keperawatan (Scientific Journal of Nursing) 9 (2), 303-309. 2023	Stikes Pemkab Jombang	Juni, 2023
31	ER Tiara, P Sopiah, H Ridwan	Pentingnya Pemeriksaan Skrining Pada Ibu Hamil Untuk Mencegah Individu Dengan Pjb	Jurnal Ilmiah Keperawatan (Scientific Journal of Nursing) 9 (2), 288-294 2023 https://www.jurnal.stikespembangkabjombang.ac.id/index.php/jikep/article/view/1492	Stikes Pemkab Jombang	Juni, 2023
32	D Azzahra, P Sopiah, H Ridwan	Korelasi Antara Kelainan Kongenital Dengan Virus Rubella Pada Ibu Hamil	Jurnal Ilmiah Keperawatan (Scientific Journal of Nursing) 9 (2), 278-28 2023 https://journal.stikespembangkabjombang.ac.id/index.php/jikep/article/view/1485	Stikes Pemkab Jombang	Juni, 2023

33	SP Amelia, P Sopiah, H Ridwan	Hubungan Patologi Dan Patofisiologi Pada Individu Akibat Normalisasi Perilaku Merokok Di Indonesia	Jurnal Keperawatan Abdurab 7 (1), 23-28 1 2023 <a href="https://jurnal.univr
ab.ac.id/index.php/
keperawatan/articl
e/view/3360">https://jurnal.univr ab.ac.id/index.php/ keperawatan/articl e/view/3360	Universitas Abdurab	Juni, 2023
34	VT Nurjanah, I Sutresna, DY Rahmat, P Sopiah	Potensi Daun Dewandaru Sebagai Obat Herbal Untuk Menurunkan Tekanan Darah Pada Hipertensi:	Jurnal Kesehatan Tambusai 4 (2), 1279-1287 2023 <a href="https://journal.univ
ersitaspahlawan.ac
.id/index.php/jkt/ar
ticle/view/14915">https://journal.univ ersitaspahlawan.ac .id/index.php/jkt/ar ticle/view/14915	Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai	Juni, 2023
35	C Komala, A Faozi, DY Rahmat, P Sopiah	Hubungan literasi kesehatan mental dengan trend self- diagnosis pada remaja akhir	Holistik Jurnal Kesehatan 17 (3), 206-213 1 2023 <a href="https://ejournalmala
hayati.ac.id/index.
php/holistik/article
/view/10125">https://ejournalmala hayati.ac.id/index. php/holistik/article /view/10125	Universitas Malahayati	Juni, 2023
36	N Sari, D Kelana, P Sopiah	Hubungan Citra Tubuh (Body Image) Dengan Status Gizi Kek Pada Siswi Smkn Sukasari	Jurnal Kesehatan Tambusai 4 (2), 954-95 2023 <a href="https://journal.univ
ersitaspahlawan.ac
.id/index.php/jkt/ar
ticle/view/15085">https://journal.univ ersitaspahlawan.ac .id/index.php/jkt/ar ticle/view/15085	Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai	Juni, 2023
37	T Aryantini, I Sutresna, DY Rahmat, P Sopiah	Mekanisme Koping Pada Mahasiswa Prodi Diii Keperawatan Yang Sedang Mengerjakan Tugas Akhir	Jurnal Kesehatan Tambusai 4 (2), 1030-1036 2023 <a href="https://journal.univ
ersitaspahlawan.ac
.id/index.php/jkt/ar
ticle/view/15033">https://journal.univ ersitaspahlawan.ac .id/index.php/jkt/ar ticle/view/15033	Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai	Juni, 2023

38	E Rahmawati, A Faozi, DY Rahmat, P Sopiah	Pengalaman Ibu Dalam Merawat Balita Stunting Usia (3-5) Tahun	Jurnal Kesehatan Tambusai 4 (2), 1079-1085 2023 https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jkt/article/view/15034	Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai	Juni, 2023
39	FD Esa, P Sopiah, R Rosyda	Hubungan aktifitas fisik dengan tingkat stres pada lansia penderita hipertensi	Jurnal Ilmu Keperawatan Komunitas 6 (1), 17-22 2023 https://journal.ppni-jateng.org/index.php/jikk/article/view/2137	PPNI Jateng	Juni, 2023
40	N Komariah, P Sopiah, R Rosyda	Gambaran Aktivitas Seksual Pada Penderita Jantung Koroner	Prepotif: Jurnal Kesehatan Masyarakat 7 (1), 996-1002 2023 https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/prepotif/article/view/13773	Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai	Juni, 2023
41	AF Rosmawati, P Sopiah, R Rosyda	Hubungan Konsep Diri Dengan Kualitas Hidup Penderita Scabies Pada Santri Di Pondok Pesantren	Prepotif: Jurnal Kesehatan Masyarakat 7 (1), 807-813 2023 https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/prepotif/article/view/13462	Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai	Juni, 2023
42	G Gani, P Haryeti, P Sopiah	Hubungan Modifikasi Gaya Hidup Dengan Pencegahan Stroke Ulang Pada Pasien Pasca Stroke Di Wilayah Kerja Puskesmas Tanjungsari	Prepotif: Jurnal Kesehatan Masyarakat 7 (1), 814-821 2023 https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/prepotif/article/view/13294	Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai	Juni, 2023

43	SNAP Bintang, P Sopiah, R Rosyda	Terapi Komplementer Yoga pada Lansia Penderita Osteoarthritis: Analisis Bibliometrik	Jurnal Penelitian Perawat Profesional 5 (3), 997-1006 2023 https://www.jurnal.globalhealthsciecegroup.com/index.php/JPPP/article/view/1650	STT Muhammadiyah Cileungsi	Mei 2023
44	IK Dewi, P Sopiah, R Rosyda	Pengaruh rebusan ketumbar untuk menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi: Narrative Literature Review	TEKNOSAINS: Jurnal Sains, Teknologi dan Informatika 10 (2), 262-266 1 2023 https://www.jurnal.sttmcileungsi.ac.id/index.php/tekno/article/view/541	STT Muhammadiyah Cileungsi	April 2023
45	RD Nuryanti, P Sopiah, R Rosyda	Efektivitas kompres hangat pada dismenore remaja perempuan: Narative literatur review	TEKNOSAINS: Jurnal Sains, Teknologi dan Informatika 10 (2), 266-273 2023 http://jurnal.sttmcileungsi.ac.id/index.php/tekno/article/view/539	STT Muhammadiyah Cileungsi	April 2023
46	R Nuryani, A Ayuningsih, SW Lindasari, D dolifah, P Sopiah	Dampak Skoliosis terhadap Psikologis Remaja	Jurnal Keperawatan 16 (1), 265-272 2024 https://journal2.stikeskendal.ac.id/index.php/keperawatan/article/view/1416	Stikes Kendal	Maret 2024
47	Amelia Cahya Putri, Heri Ridwan, Popi Sopiah	Pengaruh Yoga terhadap Penurunan Rasa Nyeri Punggung Bawah pada Ibu Hamil Trimester II dan III	Jurnal Penelitian Perawat Profesional 6 (2) 705-710 2024 https://www.jurnal.globalhealthsciecegroup.com/index.php/JPPP/article/view/2263	Global Health Science Group	April 2024

48	Munaawarotul Hidayah, Popi Sopiah, Heri Ridwan, Fitri Nurhayati, Kento Pirmanto, Nabila Rahmani, Salwa Tri Aulia	Kejadian Jatuh Pada Lansia: Faktor Risiko, Pencegahan dan Komplikasi: Literature Review	Jurnal Keperawatan Aisyiyah 11(2)	Stikes aisyiyah Bandung	Desember 2024
49	Popi Sopiah, Reni Nuryani, Nunung Siti Sukaesih, Sri Wulan Lindasari, Nurul Assyfa	The Dhikir and Prayer Therapy on Reducing Blood Pressure in Hypertension Patients: Systematic Literature Review	Care: Jurnal Ilmiah Kesehatan 12(2) 238-252 2024	Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Tribhuwana Tunggaladewi	15 Juli 2024
50	Aulia Rizky Ramadhani a, Azwaj Nailla Hasna, Rieke Kartika Winata, Heri Ridwan, Popi Sopiah	Hubungan Aktivitas Fisik dan Pola Makan terhadap Status Indeks Masa Tubuh Normal	SEHATMAS: Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat 3(1) 58-66 2024 https://www.jurnal.literasisains.id/index.php/sehatmas/article/view/3057	Literasi Sains Indonesia	28 Januari 2024

13. HKI :

No.	Nama pemegang HKI	Judul HKI	Jenis HKI	Kota	Bulan,tahun
1	Nunung Siti Sukaesih, S.Kep,MmedEd.; Ns.Hikmat Pramajati, S.Kep,MAN.; Popi Sopiah, S.Kp.,M.Biomed	Model Pendampingan teman sebaya dalam upaya peningkatan kesadaran remaja tentang kesehatan reproduksi	Resume/ringkasan	Kemenhuk HAM Jakarta Indonesia	EC00201859881, 18 Desember 2018 Nomor pencatatan : 000131045

2	Popi Sopiah, Nunung Siti S, Reni Nuryani, Novita Alviani	Mengenal Menarke Dan Perawatan Saat Menghadapi Menarke/men struasi	Karya sinematografi	Kemenhuk HAM Jakarta Indonesia	EC00201949 557, 7 Agustus 2019 Nomor pencatatan : 000150728
3	Popi Sopiah	Efek Asam galat dan senyawa turunanny a terhadap regulasi inflamasi pada kultur primer endometri osis : tinjauan terhadap ekspresi mRNA NFkB serta ekspresi TNF alpha dan IL-6	Karya tulis ilmiah	Kemenhuk HAM Jakarta Indonesia	EC00201937 344 8 April 2019 Nomor pencatatan : 000139641
4	Nunung Siti Sukaesih, S.Kep., MMedEd, Popi Sopiah, S.Kp., M.BioMed.	Modul Praktikum Anatomi Fisiologi Jilid 1	Modul	Kemenhuk HAM Jakarta Indonesia	EC00201977 781, 24 Oktober 2019
5	Reni Nuryani, Sri Wulan Lindasari, Popi Sopiah	Pedoman Deteksi Kesehatan Jiwa Keluarga Bagi Kader Kesehatan Jiwa	Buku Panduan/ Petunjuk	Kemenhuk HAM Jakarta Indonesia	EC00201984 709, 30 November 2019 Nomor pencatatan : 000167151
6	Popi Sopiah, Popon Haryeti, Dedah Ningrum	Penyebab Kolesterol Tinggi	Karya sinematografi	Kemenhuk HAM Jakarta Indonesia	EC00202037 973, 6 Oktober 2020 Nomor pencatatan : 000215733

7	Popi Sopiah, Sri Wulan Lindasari	Buku Panduan Belajar Praktik Klinik Keperawatan Dasar untuk Mahasiswa Program Studi Keperawatan	Buku Panduan/Petunjuk	Kemenhuk HAM Jakarta Indonesia	EC00202049335, 13 November 2020 Nomor pencatatan : 000218209
8	Ana Fitrianingsih, Haninan Salma Dianah, Betsy Elisse Majaya, Popi Sopiah	Flyer Produk Kemasan Masker	Karya Seni	Kemenhuk HAM Jakarta Indonesia	EC00202143650, 1 september 2021 Nomor Pencatatan 000288323
9	Popi Sopiah	Buku Panduan Pembelajaran Praktikum Ilmu Alam Dasar Keperawatan	Buku Panduan/Petunjuk	Kemenhuk HAM Jakarta Indonesia	EC00202165135, 16 November 2021 Nomor pencatatan : 000304158
10	Popi sopiah	Profil hypertension self care lansia penderitahipertensi dengan hiperkolesterol di masapandemik covid-19	Proposal Penelitian	Kemenhuk HAM Jakarta Indonesia	EC00202154108, 12 Oktober 2021 Nomor pencatatan : 000279058
11	Popi Sopiah, Rahayu Pujie Lestarie	Activity of celery leaf decoction as an effort to lower blood pressure in hypertension patient: bibliometric study	Karya tulis Ilmiah	Kemenhuk HAM Jakarta Indonesia	EC00202247672, 26 Juli 2022 Nomor pencatatan : 000363405
12	Popi Sopiah dan Zenia Kaulika Putri	Buku Obat Herbal Indonesia Untuk Penderita Hipertensi	Buku Modul pembelajaran	Kemenhuk HAM Jakarta Indonesia	EC00202251379, 8 agustus 2022 Nomor pencatatan : 000367111

13	Popi Sopiah	Buku Modul Ajar Terapi Non Farmakologis untuk Penderita Hipertensi	Buku Modul pembelajaran	Kemenhuk HAM Jakarta Indonesia	EC00202371685, 25 Agustus 2023 Nomor Pencatatan: 000504638
14					
15					

Sumedang, Januari 2025



(Popi Sopiah, S.Kp., M.Biomed)

RANCANGAN ANGGARAN PENELITIAN

NO	NAMA BARANG	QTY	HARGA	JUMLAH
1.	Hydrogel	3	Rp. 150.000	Rp. 450.000
2.	Kassa Steril	5	Rp. 10.000	Rp. 50.000
3.	Hypafix	3	Rp. 30.000	Rp. 90.000
4.	Handscoon Steril	7	Rp. 6500	Rp. 45.500
5.	Print SOP	1	Rp. 1000	Rp. 1000
6.	Print Laporan Kasus	4	Rp. 60.000	Rp. 240.000
TOTAL				Rp. 876.500